

1 感染症および炎症性疾患 infection and inflammatory disease

A 急性上気道感染症 acute upper respiratory infections

到達目標

- 急性上気道感染症の原因微生物について列挙できる
- 急性上気道感染症の症候が説明できる
- 急性上気道感染症に対する適切な治療を説明できる

病因・病態

急性上気道感染症は鼻前庭から喉頭にかけての上気道における急性感染症であり、かぜ症候群（普通感冒、急性上気道炎）、急性咽頭炎、急性喉頭炎、急性喉頭蓋炎などが疾患として含まれる¹⁾。

かぜ症候群は上気道の非特異性炎症で、ウイルスが原因微生物の80～90%を占める。原因ウイルスはライノウイルスが30～50%と最も多く、その他に、コロナウイルス、RSウイルス、インフルエンザウイルス、パラインフルエンザウイルス、アデノウイルスなども原因となる²⁾（表1）。季節はライノウイルスは秋と春、コロナウイルスやRSウイルスは冬～春における感染が多い。

急性咽頭炎は口腔咽頭や鼻咽頭の急性炎症であり、原因微生物の多くはウイルスだが、5～15%は細菌感染が原因となり、A群β溶血性レンサ球菌（以下、A群溶連菌）が原因菌として頻度が高い。その他、一部ではC群やG群の溶連菌、嫌気性菌、アデノウイルス、Epstein-Barr (EB) ウイルスや、HIV、淋菌、*Chlamydia trachomatis*も原因微生物となることがある。

急性喉頭炎は喉頭における急性炎症で、原因微生物は他の上気道炎と同様にウイルスが多い。急性喉頭蓋

炎は喉頭蓋とその周囲の炎症であり、原因菌として小児ではインフルエンザ菌b型、成人ではA群溶連菌が多い。

症候・身体所見

かぜ症候群では1～3日間の潜伏期間を経て、鼻汁、鼻閉、咽頭痛、咳嗽などの症状を呈する。発熱や全身倦怠感を伴うこともあるが、通常は3～10日間持続した後、症状は自然軽快する。身体所見は非特異的なものしかない。

急性咽頭炎では発熱と強い咽頭痛を呈し、咽頭壁や軟口蓋の発赤がみられ、扁桃の腫大や滲出物の付着がみられることもある。A群溶連菌性咽頭炎では、頻度は低いが後にリウマチ熱や急性糸球体腎炎などを発症する場合がある。

急性喉頭炎は嘔声や咳嗽が主症状となる。急性喉頭蓋炎では咽喉頭の強い疼痛と発熱に加え、喉頭蓋およびその周囲の腫脹により気道が狭窄し、呼吸困難、流涎、喘鳴などの症状をきたすことがある。

診断・検査

かぜ症候群の診断は、症状などから臨床的に行う。インフルエンザの診断には迅速抗原検査を用いることができるが、流行状況と症状から本症が疑われる場合は、臨床診断によってただちに治療を開始してもよい。

A群溶連菌性咽頭炎は咽頭ぬぐい液を用いた迅速抗原検査や細菌培養により診断する。本症の鑑別として、Centorの基準³⁾である①38℃以上の発熱、②咳嗽なし、③圧痛を伴う前頸部リンパ節腫脹、④扁桃の腫大または滲出物の4項目に、年齢の要素を加えたMcIsaacの基準（表2）⁴⁾がよく用いられる。合計ポイントが多いほど本症である可能性が高くなるが、逆にこの基準で1点以下ならばその可能性は低く細菌学的検査は不要とされる。

急性喉頭蓋炎の診断には、喉頭を観察するために耳鼻咽喉科的な診察が多くで必要となる。

治療と予後

かぜ症候群は通常は自然に軽快するため、基本的に抗菌薬による治療は不要である⁵⁾。症例により必要ならば発熱・疼痛に対してはacetaminophenや非ステ

表1 かぜ症候群の原因ウイルス

ウイルス	頻度
ライノウイルス	30～50%
コロナウイルス	10～15%
インフルエンザウイルス	5～15%
RSウイルス	5%
パラインフルエンザウイルス	5%
アデノウイルス	<5%
エンテロウイルス	<5%
ヒトメタニューモウイルス	不明
不明	20～30%

[Heikkinen T, et al : Lancet 361 : 51, 2003 より引用]